

Storia

L'istituzione del Servizio sanitario nazionale inglese (*National health service* – NHS), avvenuta nel 1948, si fondava su tre principi: l'universalità, sia in termini di accessibilità, che di onnicomprensività delle prestazioni; il finanziamento, attraverso la fiscalità generale, in virtù del quale ognuno contribuiva in base alle proprie possibilità e riceveva i servizi in relazione al bisogno; la gratuità, nel punto di erogazione delle prestazioni.

Questo modello, detto Beveridge, si distingueva dal modello Bismarck (dal nome del cancelliere tedesco che aveva promosso le assicurazioni sociali obbligatorie, la prima forma di tutela sanitaria dei lavoratori, finanziata dai contributi dei datori di lavoro e degli stessi lavoratori) non solo per l'ampiezza della copertura (l'intera popolazione) e per il tipo di finanziamento (fiscalità generale), ma anche per il ruolo attribuito allo Stato: di regolazione e controllo nel modello Bismarck, di programmazione e di gestione dei servizi nel modello Beveridge. Quest'ultimo tipo di modello fu adottato nel tempo da molti paesi, tra cui l'Italia.

Sulla scia delle privatizzazioni del governo Thatcher, nel 1991, fu varata una riforma che – mantenendo inalterati i principi fondanti del modello Beveridge – separò nettamente le funzioni d'acquisto/committenza di servizi, da quelle di produzione degli stessi. Il rationale della riforma è quello di creare la competizione tra i produttori, una competizione tutta interna al NHS, di qui il nome di *internal market*, assegnato alla formula. Dopo la vittoria elettorale dei laburisti, uno dei primi atti del governo Blair fu quello di riformare la riforma Thatcher.

Dal 2002, c'è un'inversione ad U della politica sanitaria del governo Blair: le precedenti parole d'ordine lasciano il passo ad altre di segno opposto, quali: devoluzione, competizione, mercato. Gli ospedali sono stati trasformati in fondazioni (*Foundation trust*) che incorporano al proprio interno nuovi soggetti, tra i quali anche privati, come banche e assicurazioni. Le fondazioni, a cui viene riconosciuta una sostanziale indipendenza dal governo centrale, possono acquisire fondi pubblici, ma anche capitali privati, possono fare utili e investirli.

Ai giorni nostri, dopo anni di riforme, si sono ulteriormente accentuati i processi di privatizzazione dell'assistenza sanitaria, sul versante dell'offerta e della produzione dei servizi, mentre rimane (per ora) pubblico il sistema di finanziamento del NHS, basato – come all'origine – sulla fiscalità generale.

Organizzazione

Quasi tutte le risorse finanziarie destinate al NHS provengono dal gettito fiscale generale. I regimi di tipo assicurativo sono associati ad un settore di assistenza sanitario privato, in costante espansione. Circa 6 milioni di cittadini britannici hanno sottoscritto un'assicurazione aggiuntiva contro la malattia, e tale tendenza è sempre più diffusa. Il vantaggio presentato dalle assicurazioni private è la velocità di trattamento per i problemi di piccola entità, in contrapposizione alle lunghe liste d'attesa del sistema NHS.

Un numero sempre maggiore di ospedali si è trasformato in consorzi indipendenti, invece di essere gestiti direttamente dalle Autorità sanitarie. Nel sistema britannico, il medico di base, General Practitioners, provvede allo "smistamento" dei pazienti. A parte certi casi urgenti di ricovero, la consultazione di uno specialista nell'ambito del NHS avviene sempre previa prescrizione del medico di base.

La disponibilità di personale medico del Regno Unito è fra le più basse della Comunità Europea. La percentuale dei medici di base, 41.5%, è un po' superiore alla media europea.

I medici rappresentano appena il 6.6% dell'intero organico sanitario. Gli specialisti lavorano per lo più alle dipendenze dei grandi ospedali. La maggioranza di essi, comunque, si dedica anche ad un ambulatorio privato. Quasi tutti i medici di base sono lavoratori autonomi convenzionati con il NHS.

Il personale infermieristico rappresenta solo il 19% circa dell'organico sanitario totale: la percentuale più bassa della Comunità (che ha una media del 26%). Il morale nell'ambito di questa professione è piuttosto basso, e molte sono le segnalazioni di carenza di personale dovuta alla mancanza di fondi più che alla mancanza di professionisti qualificati.

Il Sistema Sanitario Nazionale riformato, come abbiamo visto, distingue fra *purcher* (acquirente) e *provider* (fornitore). L'organizzazione acquirente è articolata in 14 regioni e 191 distretti. Un distretto sanitario tipico serve 250.000 persone. I fornitori sono gli ospedali ed i servizi sanitari municipali, e si sono trasformati in *Trust* indipendenti, direttamente responsabili per la gestione dei propri affari.

Ciascuna delle quattro nazioni costituenti il Regno Unito (Inghilterra, Galles, Scozia, Irlanda del Nord) amministra un proprio sistema sanitario pubblico che, fatte salve linee guida comuni a tutte, mantiene una propria fisionomia particolare sotto gli aspetti manageriale, finanziario e operativo. L'NHS è la più grande organizzazione pubblica non militare del mondo.

Criticità

Il numero totale di posti letto ospedalieri del SSN in Inghilterra si è più che dimezzato negli ultimi 30 anni, da circa 299.000 nel 1987/88 a 141.000 nel 2019/20, mentre il numero di pazienti trattati è aumentato in modo significativo. Il Regno Unito ha meno letti per acuti rispetto alla sua popolazione rispetto a molti sistemi sanitari comparabili.

Il numero dei posti letto ospedalieri per cure generali e acute è diminuito del 44 per cento dal 1987/88; il grosso di questo calo è dovuto alla chiusura dei posti letto, per l'assistenza a lungo termine degli anziani.

Le iniziative per moderare la domanda di cure ospedaliere spesso faticano ad avere successo: sarebbe necessario avere capacità sufficiente per fornire cure adeguate al di fuori dell'ospedale, ma l'evidenza suggerisce che la capacità di cure intermedie è attualmente sufficiente solo per soddisfare circa la metà della domanda, inoltre i tagli ai finanziamenti pubblici hanno portato a riduzioni significative dell'assistenza sociale.

Prima della pandemia di Covid-19 c'erano prove diffuse di una crescente carenza di posti letto. Nel 2019/20, l'occupazione notturna generale e acuta dei letti è stata in media del 90,2% e ha regolarmente superato il 95% in inverno, ben al di sopra del livello che considerato sicuro.

Non è ancora chiaro quando e a quale livello i letti d'ospedale si stabilizzeranno dopo la pandemia. Con ospedali messi a dura prova dalla crescente domanda, lunghe liste d'attesa a causa della pandemia, carenza di personale e molte richieste contrastanti sui budget del SSN dopo una stretta decennale di finanziamenti, ulteriori riduzioni sono sia improponibili che indesiderabili.